Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Esta pauta –de uso optativo- ha sido diseñada para facilitar a los profesionales que realizan los procesos de evaluación de NEE, en el marco del Decreto 170, la recogida de antecedentes de anamnesis relevantes del estudiante. Puede ser completada por uno o más profesionales en el proceso de detección y evaluación de las NEE que presenta el alumno(a) y de los apoyos que requiere para aprender y participar en el contexto escolar.

1. DENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre	Amareli Pascal Venegas Obreque				Sexo	F	X	M	
Fecha Nacimiento	20/06/2020	Edad actual	5 años	meses	País natal:	Chile			
Domicilio actual:	Fotógrafo Albarnoz #1024			Teléfono	652989 57.				
Lengua materna	Español	Grado dominio	comprende ☑ habla ☑ lee ☐ escribe ☑						
Lengua de uso	Español	Grado dominio	comprende ☑ habla ☑ lee ☐ escribe ☑						
Escolaridad actual:	Kínder	Establecimiento	Liceo mixto básica 1						

2. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS INFORMANTES

1. Fecha de la entrevista: 10/03/2026.	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Evelyn Obreque Uribe	Nombre:
Relación con el/la estudiante: Madre.	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):
3. Fecha de la entrevista:	4. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Relación con el/la estudiante:	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):

3. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS ENTREVISTADORES

1. Fecha de la entrevista: 10/03/2026	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: María Constanza Oyarzún	Nombre:
Rol/cargo: Ed. diferencial.	Rol/cargo:
3. Fecha de la entrevista:	3. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Rol/cargo:	Rol/cargo:

4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN QUE MOTIVA LA ENTREVISTA

Ingreso a programa de integración.
Diagnóstico TEL escuela de lenguaje.

5. ANTECEDENTES RELATIVOS AL DESARROLLO Y A LA SALUD DEL/LA ESTUDIANTE

¿El o la estudiante tiene algún diagnóstico previo? ☐ No ☑ Sí (especificar)

Pediatría:	Psicología: posible ansiedad.
Kinesiología:	Psiquiatría:
Genético:	Psicopedagogía:
Fonoaudiología:	Terapia Ocupacional:
Neurología:	Otro: Fisiatra: faltan falanges de la mano derecha.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.1. Primer año de vida

Tipo de parto: ✓ normal | | inducido | | fórceps | cesárea (señalar motivo)

Tuvo asistencia médica durante el parto? ☑ SI ☐ NO | Peso: 2,170 grm. | Talla: 45.

Señale antecedentes relevantes del Embarazo y Parto:

Prematura de 36 semanas.
Al tercer día de parto quedó hospitalizada por baja de peso e histericia.

Señale si durante los doce primeros meses de vida el niño o niña presentó:

Desnutrición	Sí	~~No~~	Traumatismos	Sí	~~No~~	Encefalitis	Sí	~~No~~
Obesidad	Sí	~~No~~	Intoxicación	Sí	~~No~~	Meningitis	Sí	~~No~~
Fiebre alta	Sí	~~No~~	Enfermedad respiratoria	Sí	~~No~~	Otra(s)		
Convulsiones	Sí	~~No~~	Asma	Sí	~~No~~			
Hospitalizaciones	Sí	No ✓	Especifique motivos y duración:					

Se realizaron controles periódicos de salud	~~Sí~~ ✓	No	Vacunas	~~Sí~~	No

Observaciones:

Sin observaciones.

5.2. Desarrollo Sensorio Motriz

Edad en que el niño (a)

Fija la cabeza:	Se sienta sólo/a: 8 meses	Camina sin apoyo: 1 año 2 meses
Primeras palabras: 7 meses	Primeras frases: 9 meses.	Se viste solo/a: 4 años
Controla esfínter vesical Diurno: ✓ Nocturno: ✓	Controla esfínter anal Diurno: ✓ Nocturno: ✓	

Observaciones:

A pesar de ser prematura, su desarrollo sensorio motriz fue normal.

En su actividad motora general se aprecia:
✓ normal ✓ activo ⁻ hiperactivo ☐ hipoactivo

Su tono muscular general se aprecia:
☑ normal ☐ hipertónico ☐ hipotónico

En relación con su motricidad gruesa se aprecia:

Estabilidad al caminar	~~Sí~~	No	Caídas frecuentes	Sí	~~No~~	Dominancia lateral derecha	Sí	No

En relación con su motricidad fina el niño (a) logra:

Garra	~~Sí~~	No	Prensión	~~Sí~~	No	Pinza	~~Sí~~	No
Ensarta	~~Sí~~	No	Dibuja	~~Sí~~	No	Escribe	~~Sí~~	No

En relación con algunos signos cognitivos el niño (a)

Reacciona a voces o caras familiares	~~Sí~~	No	Manipula y Explora objetos	~~Sí~~	No
Demanda objetos y compañía	~~Sí~~	No	Comprende prohibiciones	~~Sí~~	No
Sonríe, balbucea, grita, llora, indica o señala	~~Sí~~	No	Posee evidente descoordinación ojo-mano	Sí ✓	No

Observaciones:

Sin observaciones.
Dificultades para tomar la tijera

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.3. Visión - Audición:

Se interesa por los estímulos visuales (colores, formas, movimientos, etc.)	Sí	No	Se interesa por los estímulos auditivos (ruidos, voces, música, etc.)	Sí	No
En ocasiones tiene los ojos irritados o llorosos	Sí	No	Reacciona o reconoce voces o sonidos familiares	Sí	No
Presenta dolores frecuentes de cabeza	Sí	No	Gira la cabeza cuando se le llama o ante un ruido fuerte	Sí	No
Se acerca o aleja demasiado los objetos a la vista (frunce el ceño)	Sí	No	Acerca los oídos a la TV, radio o fuente de sonido.	Sí	No
Sigue con la vista el desplazamiento de los objetos o personas	Sí	No	En ocasiones se tapa o golpea los oídos	Sí	No
Presenta movimientos oculares "anormales"	Sí	No	Presenta frecuentes dolores de oídos	Sí	No
Manifiesta conductas "erróneas" (tropiezos, choques)	Sí	No	La pronunciación oral es adecuada	Sí	No
Presenta diagnóstico médico de miopía, estrabismo, astigmatismo, u otro.	Sí	No	Presenta diagnóstico médico de otitis crónica, hipoacusia u otra.	Sí	No

Observaciones:
le molesta los ruidos fuertes.

5.4. Desarrollo del Lenguaje

El niño (a) se comunica preferentemente en forma
☐ oral ☐ gestual ☒ mixto ☐ otro (especifique):

Características del lenguaje expresivo

Balbucea (oral o señas)/emite sonidos	Sí	No	Emite/produce frases	Sí	No
Vocaliza/realiza gestos o señas aisladas	Sí	No	Relata experiencias	Sí	No
Emite palabras/produce señas	Sí	No	La emisión/pronunciación/producción es clara	Sí	No

Características del lenguaje comprensivo

Identifica objetos	Sí	No	Sigue instrucciones simples	Sí	No
Identifica personas	Sí	No	Sigue instrucciones complejas	Sí	No
Comprende conceptos abstractos	Sí	No	Sigue instrucciones grupales	Sí	No
Responde en forma coherente preguntas de la vida diaria	Sí	No	Comprende relatos, noticias, cuentos cortos	Sí	No

Manifestó pérdida del lenguaje oral (especifique edad y motivos): No.

Observaciones:
En ocasiones se expresa con garabatos.

5.5. Desarrollo Social

Se relaciona espontáneamente con las personas de su entorno natural.	Sí	No	Se relaciona en forma colaborativa	Sí	No
Explica razones de sus comportamientos y actitudes	Sí	No	Respeta normas sociales	Sí	No
Participa en actividades grupales	Sí	No	Respeta normas escolares	Sí	No
Opta por trabajo individual	Sí	No	Muestra sentido del humor	Sí	No
Presenta lenguaje ecolálico	Sí	No	Movimientos estereotipados	Sí	No
Exhibe dificultad para adaptarse a situaciones nuevas	Sí	No	Pataletas frecuentes	Sí	No

Ante los siguientes estímulos su reacción es:

Luces:	**Sonidos:**	**Personas extrañas:**
☐ natural ☒ desmesurada	☒ natural ☐ desmesurada	☒ natural ☐ desmesurada

Observaciones:
Se relaciona con las personas que ella quiere.
Le molesta la luz se enoja.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.6. Estado Actual de Salud del/la Estudiante					
Vacunas al día	~~Sí~~	No	Trastorno motor	Sí	~~No~~
Epilepsia	Sí	~~No~~	Problema bronco-respiratorio	Sí	~~No~~
Problemas cardiacos	Sí	~~No~~	Enfermedad infecto-contagiosa	Sí	~~No~~
Paraplejia	Sí	~~No~~	Trastorno emocional	Sí	~~No~~
Pérdida auditiva	Sí	No	Trastorno conductual	Sí	~~No~~
Pérdida visual	Sí	~~No~~	Otro (especifique):		

El o los problemas de salud reciben control/tratamiento (especifique):

Alimentación: ☒ normal ☐ "malo/a" para comer ☐ "bueno/a" para comer ☐ Otro (especifique) Selectiva.

Peso (apreciación del informante): ☒ normal ☐ bajo peso ☐ obesidad

Sueño: ☐ normal ☐ tranquilo ☒ inquieto Horas que duerme: 9 - 10 horas.

☐ insomnio ☒ pesadillas ☐ terrores nocturnos
☐ sonambulismo ☒ despierta de buen humor

Duerme: ☐ solo ☒ acompañado
(Especifique): papá y mamá.

Humor/comportamiento ***(señale el comportamiento habitual)***

☒ alegre ☐ juguetón/bromista ☒ risueño(a) ☐ triste ☒ serio ☐ rebelde ☐ apático ☐ violento(a)
Otro:

Observaciones:

Sin observaciones.

6. ANTECEDENTES FAMILIARES

Personas que viven con el niño o niña y/o que son que son responsables de su cuidado.

Nombre	Parentesco	Edad	Escolaridad	Ocupación actual
1. Evelyn Obreque	Madre	44	4to med.	Dueña de casa.
2. Andres Venegas	Padre	44	2do medio	Chofer transporte.
3. Dalanzon Venegas	hermano	21	Univ.	Estudiante.
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Antecedentes de Salud de la Familia

(Señale aquellos antecedentes que son relevantes en función de la entrega de apoyos que requiere el o la estudiante):

Madre en observación por cancer ovarico.

Observaciones:

Sin observaciones.

LOS DATOS CONTEN

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

7. ANTECEDENTES ESCOLARES Y APOYO DE LA FAMILIA

Trayectoria escolar

Edad de ingreso al sistema escolar	3 años	Asistió a jardín infantil	Sí ✓	No
N° de colegios en que ha estudiado	2	Modalidad de enseñanza Regular ☐ Especial ✓ Técnica ☐:		
Motivo de los cambios: Decisión de la madre.				
Ha repetido curso/s	Sí	No ✓	Curso(s)	Motivo:

Situación actual

Nivel/curso actual	K° C		**Dificultad de aprendizaje**	Sí	No ✓	**Dificultad para participar**	Sí	No ✓	**Conducta disruptiva**	Sí ✓	No
Asiste regularmente	Sí ✓	No	Asiste con agrado	Sí ✓	No	Apoyo familiar en tareas	Sí ✓	No	Amigos (as)	Sí ✓	No

Actitud de la familia

¿Cómo evalúa la familia el desempeño escolar del estudiante?
✓ satisfactorio ☐ insatisfactorio (motivos) .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a las dificultades escolares del estudiante?
✓ apoyo ☐ castigo ☐ indiferencia ☐ compasión ☐ tensión ☐ otra .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a los éxitos escolares del estudiante?
✓ apoyo ☐ indiferencia ☐ otra .....
Especifique el tipo de refuerzos o premios:
☐ expresiones afectivas ✓ alimentos preferidos ☐ ver TV ✓ juguetes ☐ tiempo libre ☐ otro(s).....

¿Quiénes apoyan el proceso de aprendizaje y desarrollo del estudiante?
✓ madre ✓ padre ✓ hermanos/as ☐ Otros familiares Otros profesionales .....

¿Qué expectativas muestra la familia frente al futuro escolar del estudiante?
✓ alta (incluye al grupo familiar) ☐ mediana (incluye sólo madre/padre) ☐ baja (no incluye a ningún miembro)

¿Ofrece la familia un ambiente físico y emocional adecuado para el aprendizaje?
✓ Ambos ☐ Sólo físico (espacios, materiales, ventilación, luminosidad) ☐ Sólo emocional (tranquilo, relajado, comprensivo)

Comentarios u otras observaciones relevantes que no se han registrado o explorado:

Actualmente se encuentra con atención psicologica y fisiatrica por falta de falanges en la mano derecha.

Psicologica porque se come los cuticos de los dedos, se autolesiona.

Se encuentra en investigación por situación ocurrida en escuela de lenguaje

5

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY